

·医疗损害·

IVF-ET 术后稽留流产致孕妇死亡医疗损害 1 例

童 昉¹,黄泉源²,杨 怡¹,张 琳¹,梁 悦¹,李文鹤¹,周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030; 2. 恩施州土家族苗族自治州公安局,湖北 恩施 445400)

关键词: 法医病理学; 流产,稽留; 胚胎移植; 体外受精; 多囊卵巢综合征; 医疗损害

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2017.06.024

文章编号: 1004-5619(2017)06-0669-02

1 案 例

1.1 简要案情

杨某,女,22岁,生前因原发性不育至某医院生殖中心就诊,影像学检查示多囊卵巢综合征(polycystic ovarian syndrome,PCOS)及双侧输卵管梗阻。杨某在该院行冻融体外受精-胚胎移植(*in vitro* fertilization-embryo transfer,IVF-ET)术,术后出现稽留流产并严重感染征象,于2012年3月6日(IVF-ET术后4个月)死亡。杨某家属认为医方在诊疗过程中存在过错,并因此造成杨某死亡。

1.2 病史摘要

2011年6月21日主诉:原发不孕1年6个月。平素月经不规律,量少,痛经(+).B超示:双侧卵巢多囊样改变。行子宫输卵管造影术(hysterosalpingography,HSG)示:双侧输卵管梗阻。初步诊断:原发性不孕,多囊卵巢综合征,双侧输卵管梗阻。

2011年12月14日,杨某行冻融IVF-ET术。

2012年1月11日,行B超见子宫内11mm×5mm大小妊娠囊回声,可见胚芽,未及胎心搏动,提示宫内早孕。

2012年1月30日,查人绒毛膜促性腺激素(β -human chorionic gonadotropin, β -HCG)41253mIU/mL(正常参考值<5.0mIU/mL)。

2012年2月8日,杨某因阴道不规则流血并发热、咳嗽等先兆流产及感染征象至医院就诊,由于B超检查到胎儿仍有胎心搏动,并且考虑系珍贵胎儿,故选择住院保胎。住院期间,院方给予杨某戊酸雌二醇、黄体酮及地屈孕酮保胎,头孢曲松钠抗感染,布洛芬对

症处理,阴道流血停止,但感染征象仍不见好转,甚至加重,体温最高达38.9℃,咳嗽频发。

2012年2月14日,B超提示胚胎停育(胚胎约9周大小),建议终止妊娠,并择期行刮宫术。

2012年2月14日至20日,医方除给予杨某头孢曲松抗感染治疗外未做其他处理或检查。

2012年2月21日,杨某行刮宫术终止妊娠。术前置血常规示:白细胞 $9.08 \times 10^9/L$,红细胞 $4.74 \times 10^{12}/L$,血红蛋白138.0g/L,血小板 $142.0 \times 10^9/L$,中性粒细胞相对值91.7%,淋巴细胞相对值4.8%。胸部X线片见双肺广泛性渗出,呈磨玻璃样改变。术中宫内胚物及组织送病理学检验,镜下见完整胚胎及大量绒毛结构,可见灶、片状出血及数量不等的炎症细胞浸润。

2012年2月22日至3月6日,杨某术后感染征象依然不减。医方于2月22日请血液科、内分泌科会诊,并行骨穿及相关激素水平检查,排除了杨某患血液病及内分泌疾病可能。期间杨某体温最高达40.2℃,血压及血氧饱和度低,通过药物维持,经联合使用抗生素依然未见好转。2012年3月6日,杨某因故出院,在回家途中死亡。出院诊断:稽留流产,肺部感染,急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS),脓毒血症。

1.3 法医学鉴定

1.3.1 死因推断

本例死者因故未行尸体解剖,但根据其临床表现及病程发展,可以推断其死亡原因,并作为本案医疗损害责任认定的基础。杨某起初仅表现为先兆流产,在明确稽留流产后,相继出现严重肺部感染、ARDS、全身感染并脓毒血症等征象,分析认为杨某的病程以稽留流产为起点,随后进行性加重。综上,根据杨某病程发展特点,死因符合稽留流产继发宫内及全身感染,最终因多器官功能衰竭死亡。

1.3.2 医疗责任认定

医方在明确杨某稽留流产并有发热、咳嗽的情况

基金项目:“十三五”国家重点研发计划资助项目(2016YFC0800701);中央高校基本科研业务费资助项目(2016JCTD117)

作者简介:童昉(1989—),男,博士研究生,主要从事法医病理学研究;E-mail:drtongfang@163.com

通信作者:周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学研究、检案及教学工作;E-mail:450654925@qq.com

下,未及时给予刮宫术以控制感染,贻误病情,并且在病原学检查方面存在疏漏。上述失误与杨某后期出现严重脓毒血症及肺部感染继发 ARDS 存在直接关联,故在患者死亡结果中应承担主要责任。

2 讨 论

2.1 稽留流产的诊断与治疗

稽留流产又称过期流产,是最常见的流产形式^[1],指胚胎或妊娠不满 28 周的胎儿已死亡滞留宫腔内未能及时自然排出者,临床表现为早孕反应消失,有先兆流产症状或无任何症状^[2]。稽留流产若处理不当或不及时可能致命,宫内死亡的胚胎会溶解坏死,继而释放凝血活酶等物质进入母体血液循环,引起凝血功能障碍,如弥散性血管内凝血 (disseminated intravascular coagulation, DIC)^[3-4]。

稽留流产的治疗较为困难,对于孕期<12 周的孕妇,可行刮宫处理,但应完善术前检查,尤其是血常规及凝血功能,存在异常者,应行相应处理,待指标恢复正常后择期在麻醉下进行刮宫^[1-2];对于孕期>12 周的孕妇,则可使用缩宫素促使胎儿及胎盘自然排出^[2]。本例中,杨某胚胎停育约在孕 9 周,医方选择行刮宫术的处理基本符合诊疗常规。

临床上对于稽留流产的诊断主要依靠 B 超和临床表现^[2,5],对于有不明原因的阴道流血伴腹痛的孕妇,应行 B 超检查,若未见胎心搏动,则应考虑稽留流产可能。

2.2 辅助生殖技术与稽留流产的关联

辅助生殖技术 (assisted reproductive technology, ART) 指采用医疗辅助手段治疗不孕不育的技术,主要包括人工授精和 IVF-ET 两大类。据 WANG 等^[6]研究,ART 怀孕流产率较高,在 18%~30%。本例医方运用的 IVF-ET 术是最广泛使用的 ART 技术。有研究^[7]表明,IVF-ET 术后流产与年龄、内分泌水平等因素有关。本例死者年龄较小,但其本身患有多囊卵巢综合征,体内黄体生成素水平较高。WESTERGAARD 等^[8]认为高黄体生成素与不孕、流产密切相关,因此认为杨某患有多囊卵巢综合征与本次稽留流产存在关联。

2.3 死因与医疗过错分析

理清稽留流产、宫内感染、重症肺炎与死亡的内在联系是本案鉴定的要点。

杨某于 2011 年 12 月 14 日行冻融 IVF-ET 术,2012 年 1 月 11 日 B 超及 1 月 30 日 β -HCG 检查的结果,可以明确其宫内早孕,植入胚胎存活。2 月 8 日杨某出现先兆流产合并肺部感染征象,B 超示胎心搏动仍然存在,但未行 β -HCG 检查。在住院保胎治疗

期间,杨某的感染征象加重,2 月 14 日确诊为稽留流产,于 2 月 21 日行刮宫术后联合运用抗生素,感染仍未得到控制,肺部病变继续加重,胸部 X 线片见双肺广泛性渗出,并出现脓毒血症。根据上述病程,推测植入的胚胎系于 2012 年 2 月 8 日至 14 日之间死亡,期间未见医方给予任何胎儿监测或评价怀孕情况的检查,尤其是未监测血清或尿 β -HCG 水平,存在监护不当的过失,失去了“早发现、早治疗”的时机。除此之外,医方自 2 月 14 日确诊稽留流产,且存在感染征象,至 2 月 21 日才实施刮宫术,期间除给予头孢曲松钠抗感染外未做其他处理,导致死者病情进一步加重,客观上延误了治疗时机,存在过失,与死者病程后期出现脓毒血症及严重肺部感染有直接因果关系,最终致其因多器官功能衰竭而死亡。

另外,根据死者的感染特点以及胸部 X 线片所见,医方还需要考虑支原体或病毒感染的可能,而非单纯细菌感染,尤其是在大量联合运用抗生素抗感染治疗无效的情况下,更应该考虑混合感染的可能性。因此,医院在病原体的检查和确定方面存在不足。

综上,杨某本身病情并不复杂,但医方在处理的时机上存在重大失误,一定程度上延误了治疗时机:(1)在杨某出现肺部感染合并先兆流产后未加强胎儿的监测;(2)在确诊稽留流产后未及时行刮宫术;(3)后期治疗中,医方的处理基本符合治疗原则,但未考虑细菌感染合并支原体或病毒感染的可能,在抗感染治疗上不具有针对性。

2.4 经验交流

本例系多囊卵巢综合征患者行 IVF-ET 术后出现稽留流产最终死亡,对临床及法医学工作具有一定借鉴价值。对于通过 IVF-ET 术进行胚胎植入的患者,若有先兆流产征象,医方应严密通过 B 超及 β -HCG 检查监控孕妇宫内胎儿情况。若出现感染征象,应首先考虑稽留流产可能,同时完善相关检查,以确定进一步治疗方案。在明确胎心停搏的情况下,医方应注意预防及控制感染,及时刮宫终止妊娠。

未行尸体检验明确死因是本例的不足之处,但此现象在医疗损害鉴定中时有发生,在处理此类案件时,应当十分慎重,不仅要對病历材料进行仔细审核,还应尽量完整收集影像学及组织病理学检验等其他相关资料,并进一步结合被鉴定人病程进展及死亡过程,综合分析死亡原因,在此基础上对医疗损害责任进行认定。

参考文献:

- [1] JURKOVIC D. Modern management of miscarriage: is there a place for non-surgical treatment?[J]. Ultrasound Obstet Gynecol, 1998, 11(3): 161-163. (下转第 673 页)

南的滞后性,当某种治疗方法尚未成为成熟的常规疗法时,其医疗损害鉴定依据如何确定需要明确。笔者认为,应注意检索文献,了解国内现状,理清不同学术流派观点,综合评价。(2)在评价医疗行为时,不仅应综合考虑诊断、处理及并发症防范等诸项指标是否存在过失行为,对于新出现的联合治疗方法,尤其需注意可能的叠加损害。(3)对于新技术、新疗法医疗损害鉴定时,有必要考虑促进医学科技发展与保护患者权益的平衡,区分诊断治疗与告知信息情境的不同,适度提高告知义务权重^[9]。

参考文献:

- [1] 谢幸,苟文丽. 妇产科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2013:310-313.
 - [2] 乐杰. 妇产科学[M].5版.北京:人民卫生出版社,2001:323-327.
 - [3] 罗新,沈媛,宋雯霞,等. 射频消融术靶位治疗子宫肌瘤临床疗效研究[J].中国实用妇科与产科杂志,2007,23(8):605-608.
 - [4] 陈萍. 超声引导下射频消融治疗子宫肌瘤的近期与远期疗效研究[J].中国医学创新,2011,8(1):8-10.
 - [5] 尹格平. 射频消融治疗子宫肌瘤疗效评价[J].中国实用妇科与产科杂志,2012,26(12):908-911.
 - [6] 林穗青,李红,程利南,等. 连续口服小剂量米非司酮对卵巢功能及子宫内膜发育的影响[J].复旦学报(医学版),2002,29(4):235-238.
 - [7] 罗方素. 射频消融术联合米非司酮治疗子宫肌瘤 90 例临床分析[J].中国医药指南,2013(26):451-452.
 - [8] 毛连梅,何小红,田春丽,等. 射频消融技术配合米非司酮治疗子宫肌瘤 530 例临床观察[J].中外医学研究,2012,10(8):52-53.
 - [9] 赵西巨. 医生对新疗法的使用和告知[J].东方法学,2009(6):119-133.
- (收稿日期:2016-08-09)
(本文编辑:王亚辉)
-
- (上接第 670 页)
- [2] 谢幸,苟文丽. 妇产科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2013:49-50.
 - [3] 徐增祥,史常旭. 现代妇产科治疗学[M].北京:人民军医出版社,2002:299.
 - [4] CUNNINGHAM G F, LEVENO K J, BLOOM S L, et al. Williams obstetrics[M]. 24th. USA: McGraw-Hill Education,2013.
 - [5] DOUBILET P M, BENSON C B, BOURNE T, et al. Diagnostic criteria for nonviable pregnancy early in the first trimester[J]. N Engl J Med,2013,369(15):1443-1451.
 - [6] WANG J X, NORMAN R J, WILCOX A J. Incidence of spontaneous abortion among pregnancies produced by assisted reproductive technology[J]. Hum Reprod, 2004,19(2):272-277.
 - [7] 吕永焕,宋学茹,王艳霞. IVF/ICSI 妊娠后发生早期流产的相关因素分析[J].中国计划生育学杂志,2010,18(11):683-686.
 - [8] WESTERGAARD L G, LAURSEN S B, ANDERSEN C Y. Increased risk of early pregnancy loss by profound suppression of luteinizing hormone during ovarian stimulation in normogonadotrophic women undergoing assisted reproduction[J]. Hum Reprod, 2000, 15(5):1003-1008.
- (收稿日期:2015-05-29)
(本文编辑:邹冬华)